

指南与共识

痔诊疗日间手术专家共识(2020 年版)



专家组成员(排名不分前后): 陈希琳¹, 陈朝文², 段宏岩¹,
冯六泉³, 姜国丹⁴, 贾 山¹, 康春博⁵, 李东冰⁶, 李建平⁷, 李恒爽⁸, 李进军⁹,
林林¹⁰, 孟庆成¹¹, 荣文舟⁷, 任 毅¹², 孙亚玲¹³, 谭嗣伟¹⁴, 王晓锋¹⁵,
王 霆¹⁶, 王正亮¹, 王万民¹⁷, 杨 波¹⁸, 杨士斌¹⁹, 朱慧卿²⁰, 张书信²¹,
张树荣²², 张淑伶²³, 张卫国²⁴, 邹贤军²⁵, 赵 燕²⁶

(北京肛肠学会专家共识审定委员会: 1. 北京市肛肠医院, 北京, 100120; 2. 北京大学第三医院, 北京, 100083;
3. 空军特色医学中心, 北京, 100190; 4. 首都医科大学附属北京潞河医院, 北京, 101149;
5. 首都医科大学附属北京康复医院, 北京, 100041; 6. 中国中医科学院西苑医院, 北京, 100091;
7. 首都医科大学附属北京中医医院, 北京, 100010; 8. 首都医科大学附属北京朝阳医院, 北京, 100020;
9. 首都医科大学附属北京安贞医院, 北京, 100029; 10. 山东省烟台白石肛肠医院, 山东 烟台, 264000;
11. 航天中心医院, 北京, 100049; 12. 北京市石景山中医医院, 北京, 100191;
13. 新疆医科大学附属哈密市中心医院, 新疆维吾尔自治区 哈密, 839000;
14. 首都医科大学附属北京友谊医院, 北京, 100050; 15. 中国中医科学院广安门医院, 北京, 100053;
16. 河北省廊坊市人民医院, 河北 廊坊, 065000; 17. 湖北省国药东风花果医院, 湖北 武汉, 442049;
18. 解放军总医院第八医学中心, 北京, 100091; 19. 中国航天科工集团 731 医院, 北京, 100074;
20. 北京电力医院, 北京, 100073; 21. 北京中医药大学附属东直门医院, 北京, 100700;
22. 首都医科大学附属北京同仁医院, 北京, 100730; 23. 北京市平谷区中医院, 北京, 101200;
24. 北京市平谷区医院, 北京, 101200; 25. 湖北省武汉市第八医院, 湖北 武汉, 430000;
26. 战略支援部队特色医学中心, 北京, 100101)

摘 要: 随着加速康复外科及微创技术的不断完善, 患者对日间手术的要求更为迫切。因此, 对痔日间手术进行规范化管理, 实现肛肠外科无痛病房规范化的疼痛管理就显得尤为重要。针对痔日间手术的特点、麻醉方式的选择、手术相关注意事项等问题, 北京肛肠学会组织了 30 位国内肛肠研究领域专家, 结合循证医学证据进行反复讨论, 通过问卷调查的方法, 形成了适合当前中国国情的痔日间手术规范化管理和实施的方案, 即《痔诊疗日间手术专家共识(2020 年版)》, 也为肛肠外科无痛病房建设项目中的日间手术管理提供了决策基础。

关键词: 北京肛肠学会; 痔; 日间手术; 专家共识; 肛肠外科; 无痛病房建设; 疼痛管理

中图分类号: R 657.1 文献标志码: A 文章编号: 1672-2353(2020)10-001-08 DOI: 10.7619/jcmp.202010001

Consensus of experts on daytime operation for hemorrhoid diagnosis and treatment (2020 Edition)

CHEN Xilin¹, CHEN Chaowen², DUAN Hongyan¹, FENG Liuquan³,
JIANG Guodan⁴, JIA Shan¹, KANG Chunbo⁵, LI Dongbing⁶, LI Jianping⁷,
LI Hengshuang⁸, LI Jinjun⁹, LIN Lin¹⁰, MENG Qingcheng¹¹, RONG Wenzhou⁷,
REN Yi¹², SUN Yaling¹³, TAN Siwei¹⁴, WANG Xiaofeng¹⁵, WANG Ting¹⁶,
WANG Zhengliang¹, WANG Wanmin¹⁷, YANG Bo¹⁸, YANG Shibin¹⁹,
ZHU Huiqing²⁰, ZHANG Shuxin²¹, ZHANG Shurong²², ZHANG Shuling²³,
ZHANG Weiguo²⁴, ZOU Xianjun²⁵, ZHAO Yan²⁶



收稿日期: 2020-02-23 录用日期: 2020-04-25
基金项目: 北京肛肠学会科研专项基金(2020ABCP003)
通信作者: 谢振年, E-mail: xiezhenian@163.com
主要起草人: 王芳丽, 谢振年, 苗春红, 冷涛
总审校人: 李东冰

(Expert Consensus Approval Committee of Beijing Anorectal Society; 1. Beijing Anorectal Hospital, Beijing, 100120; 2. The Third Hospital of Peking University, Beijing, 100083; 3. Air Force Characteristic Medical Center, Beijing, 100190; 4. Beijing Luhe Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 101149; 5. Beijing Rehabilitation Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100041; 6. Xiyuan Hospital of Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing, 100091; 7. Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100010; 8. Beijing Chaoyang Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100020; 9. Beijing Anzhen Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100029; 10. Yantai Baishi Anorectal Hospital, Yantai, Shandong, 264000; 11. Aerospace Center Hospital, Beijing, 100049; 12. Shijingshan Hospital of Traditional Chinese Medicine, Beijing, 100191; 13. Hami Central Hospital Affiliated to Xinjiang Medical University, Hami, Xinjiang Uygur Autonomous Region, 839000; 14. Beijing Friendship Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100050; 15. Guang'anmen Hospital of China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, 100053; 16. Langfang People's Hospital, Langfang, Hebei, 065000; 17. Sinopharm Dongfeng Huaguo Hospital in Hubei Province, Wuhan, Hubei, 442049; 18. The Eighth Medical Center of General Hospital of People's Liberation Army, Beijing, 100091; 19. The 731st Hospital of China Aerospace Science and Industry Corporation, Beijing, 100074; 20. Beijing Electric Power Hospital, Beijing, 100073; 21. Dongzhimen Hospital Affiliated to Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Beijing, 100700; 22. Beijing Tongren Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing, 100730; 23. Pinggu District Hospital of Traditional Chinese Medicine, Beijing, 101200; 24. Pinggu District Hospital, Beijing, 101200; 25. Wuhan Eighth Hospital in Hubei Province, Wuhan, Hubei, 430000; 26. Characteristic Medical Center of Strategic Support Force, Beijing, 100101)

ABSTRACT: With the continuous improvement of accelerated rehabilitation surgery and minimally invasive technology, patients' requirements for daytime surgery are more urgent. Therefore, it is very important to standardize the management of daytime operation for hemorrhoids and realize the standardized pain management of painless ward in anorectal surgery department. According to the characteristics of daytime operation, the choice of anesthesia mode, operation-related precautions and other issues relating to hemorrhoid, this study performed questionnaire surveys for 30 domestic experts in anorectal research field invited by Beijing Anorectal Society, and finally formed a standardized management and implementation plan for hemorrhoid daytime operation after repeated discussion based on evidence-based medicine that is suitable for the current situation in China, namely Consensus of experts on daytime operation for hemorrhoid diagnosis and treatment (2020 Edition), which also provides decision-making basis for daytime operation management of construction projects in painless ward of anorectal surgery department.

KEY WORDS: Beijing Anorectal Society; hemorrhoids; daytime operation; expert consensus; anorectal surgery department; construction of painless ward; pain management

随着加速康复外科及微创技术的不断进步和完善,北京肛肠学会联合北京众新胃肠肛门病研究所于2015年开始大力倡导的肛肠外科无痛病房规范化建设项目在全国多家医院实施,使得日间手术作为一种简单的治疗康复模式,开始逐渐受到临床医护人员和患者的青睐。

痔是临床常见病,手术治疗是其有效的治疗手段,但伴随术后剧烈的伤口疼痛和出血,患者耐

受程度降低,限制了日间手术的深入开展。目前,微创手术和创面修复技术的日趋完善以及北京肛肠学会无痛病房的建立,为痔日间手术的顺利实施提供了必要条件。但痔患者是否适合进行日间手术,仍要充分考虑当地的医患关系、患者及家属的依从性、患者居住地与医院的距离、手术医生处理术后突发事件的能力等因素。行日间手术的患者要完善常规术前检查(包括血常规、感染疾

病筛查、肝肾功能、心电图、胸片等,其他根据患者本身合并症进行检查),以保证患者的医疗安全,避免医疗纠纷的发生。

当前,关于痔日间手术诊疗过程中遇到的一些具体技术问题尚无统一的意见,为了加速患者的康复,减少医疗费用的支出,辅助基层医院安全、顺利地开展,同时使具体医疗技术工作有据可循。北京肛肠学会依据学科的发展和积累的丰富临床经验,组织国内部分肛肠研究领域的专家就当前临床中遇到的一些问题开展多次研讨,制定了本专家共识。

本共识采用问卷调查法,共调研了 30 位专家,问卷回收率 100%,具有代表性。我们将 75.0% 以上的专家同意界定为“专家支持该推荐意见”,75.0% 以上的专家反对界定为“专家不支持该推荐意见”,需要新的临床研究证据来证实或否定。对于暂时无法达成一致的推荐意见,引用循证医学文献,提出推荐意见供临床参考。以前瞻性对照研究作为证据的意见等级强;反之,源于专家共识或回顾性研究的内容等级弱。

问题 1: 哪种类型的痔适合日间手术?

推荐: 对患者进行个体化评估、掌握好适应征、无麻醉及手术禁忌证、选择适宜的术式均可行日间手术。

证据等级较强,推荐等级较强。

评论: 62.3% 专家认为Ⅲ、Ⅳ度内痔可行日间手术,70.0% 专家认为混合痔患者外痔切口不超过 5 处可行日间手术,90.0% 专家认为合并血栓性外痔不超过 2 个象限可行日间手术,46.7% 专家认为各种类型的痔均适合日间手术。在欧美发达国家,常见直肠肛门疾病的手术多数可选择日间手术模式,可筛选适宜的患者实施日间手术。在实施日间手术前,需要综合考虑患者的期望值、医疗安全风险和并发症等因素,对患者进行个体化评估^[1-2]。

问题 2: 哪种术式适合日间手术?

推荐: 掌握好手术适应征及操作技巧并采取个体化治疗方案,各种痔均可行日间手术。

证据等级弱,推荐等级较强。

评论: 60.0% 专家认为外剥内扎术不超过 5 处适合日间手术,96.7% 专家认为套扎术不超过 3 处适合日间手术,30.0% 专家认为痔上黏膜环切术(PPH)或选择性痔上黏膜吻合术(TST)适合日间手术,90.0% 专家认为铜离子电化学疗

法^[3-7]适合日间手术,96.7% 专家认为注射疗法适合日间手术。

问题 3: 对于高龄(大于 75 岁)、合并基础疾病多(合并 3 种以上的心脑血管疾病)的痔患者,是否可行日间手术?

推荐: 个体化评估,根据患者基础疾病的具体情况决定。

证据等级一般,推荐等级一般。

评论: 3.3% 专家认为可行日间手术,70.0% 专家认为尽量不行日间手术,因为患者耐受性差,术后风险增加。33.3% 专家认为若基础疾病控制平稳,可行日间手术。中国日间手术的定义^[8-9]: 手术患者有计划地在入院前安排完成术前检查、麻醉评估、预约手术时间等,当日入院并手术,同时于术后 24 h 内出院的手术(不含门诊手术),一些特殊患者因病情需要延期出院的,住院时间最长不超过 48 h。研究^[10]提出排除标准有: ① 凝血功能障碍; ② 肝肾功能严重障碍; ③ 美国麻醉医师协会(ASA)病情分级大于Ⅱ级; ④ 依从性较差或存在精神障碍者; ⑤ 妊娠期妇女。目前痔日间手术纳入标准尚不统一,对于保守治疗失败或不能耐受门诊手术的混合痔患者,高龄及基础疾病多并非禁忌证^[11],只要基础疾病控制平稳,可行日间手术。拟行手术的麻醉方式、手术级别、设备条件、外科及麻醉医师的技术操作能力、医患沟通情况、患者医嘱执行情况、生活自理能力等因素,都将决定患者是否适合实施日间手术^[12]。麻醉评估 ASA Ⅲ级的患者,在密切监测的情况下,全身状况稳定 3 个月以上者,可以行日间手术^[13]。可以采用“入院标准宽,出院标准严”策略,若患者出现不适症状,应果断停止出院。

问题 4: 痔日间手术适合何种麻醉方式?

推荐: 局部浸润麻醉、蛛网膜下腔阻滞麻醉、骶管麻醉、静脉麻醉加局麻均可,根据患者情况及术式选择。

证据等级较强,推荐等级较强。

评论: 96.7% 专家认为可选择局部浸润麻醉,86.7% 专家认为可采用骶管麻醉,46.7% 专家认为可采用蛛网膜下腔阻滞麻醉,50.0% 专家认为可选择静脉麻醉加局部浸润麻醉。研究^[14-16]报道局部使用浸润麻醉结合监测下麻醉管理对肛门手术可能更安全,比其他麻醉方式的并发症更少,局部麻醉加监测下麻醉管理患者的麻醉时间、进食时间明显缩短,术后恶心、呕吐发

生率也更低,患者更有可能在术后6 h内出院。

问题5: 术后是否需要换药? 换药频率?

推荐: 术后需要换药,换药频率可采取2次/周或隔日1次。

证据等级强,83.3%专家赞同,推荐等级强。

评论: 目前痔的手术方式很多,一些针对内痔的手术方式如吻合器手术、铜离子电化学疗法^[17-18]、套扎疗法、注射疗法等无外痔创面,术后不需要换药(2周以后指诊1次)。如果合并有外痔创面,当日不需要换药,次日开始换药,并可指导患者采取中药外敷、坐浴。研究^[19-20]报道选择中药坐浴可以改善术后水肿、渗出及疼痛情况,促进伤口愈合,每日2次的坐浴^[21]能保持创面清洁,减轻创面炎症反应,同时可抑制创面细菌繁殖,促进局部血液循环,有利于肉芽组织的生长和上皮的形成,促进创面愈合,坐浴后可配合使用具有止痛、抗感染作用的膏剂、栓剂塞肛(栓剂塞肛时务必涂抹膏剂并注意方向)。医生换药可以采取2次/周或者隔日1次的方式,每日换药可能是多余的,且失去了日间手术的意义。术后伤口处理不到位可能会导致感染甚至桥形愈合,但过度换药不仅增加患者经济负担,对患者造成不必要的痛苦,而且会影响伤口愈合,延长恢复时间^[22]。

问题6: 术后温水坐浴是否会增加感染概率?

推荐: 不会增加感染概率。

证据等级强,80.0%专家赞同,推荐等级强。

评论: 患者每日多次温水自行冲洗、浸泡肛门是必不可少的环节,温水坐浴不仅具有清洁局部皮肤、改善局部血液循环的作用,还具有去除污物、消除炎症、预防感染、缓解疼痛的效果,而且中药坐浴效果更好,可降低患者伤口感染概率,缩短患者症状改善时间,提高患者疗效^[23]。

问题7: 术后镇痛药物、镇痛方式如何选择?

推荐: 多模式镇痛,手术结束时可给予肛周亚甲蓝等局部封闭,术后口服阿片类或非甾体类药物,中药坐浴、美辛唑酮栓纳肛,局部外用利多卡因软膏、硝酸甘油软膏等。

证据等级强,83.3%专家赞同,推荐等级强。

评论: 良好的镇痛对日间手术后患者生活质量提升、加快康复等至关重要^[24],对于轻、中度疼痛,可选用非甾体类抗炎药,如布洛芬、对乙酰氨基酚等,中、重度疼痛可选用阿片类药物。目前临床多采用多模式镇痛^[25],较单一模式更为安全、有效、副作用小。中药坐浴及外敷^[26]以及一

些外用膏剂、栓剂可作用于术区,通过肛管、直肠黏膜吸收,具有作用直接、起效快的特点,如吲哚美辛栓、硝酸甘油软膏等。注射剂一般于痔手术结束时用,如亚甲蓝注射液、罗哌卡因注射液等,可起到长效镇痛、超前镇痛的作用。

问题8: 术后如何指导正确的饮食?

推荐: 根据麻醉要求决定进食时间。

证据等级弱,推荐等级较强。

评论: 16.7%专家认为术后进流食,36.7%专家认为术后可正常饮食,禁食辛辣刺激及可能导致腹泻的食物,保持成形软便即可,90.0%专家认为局麻术后即可进食,70.0%专家认为骶麻术后2 h进食,56.7%专家认为腰麻术后6 h进食。因此,痔术后当日进食主要依据麻醉的要求,随着腰麻和骶管麻醉技术的进步,医生可以根据麻醉情况确定相应的进食时间,但总体来说术后最早进食时间最好不小于4 h,一定不能小于2 h,24 h内勿食用可能引起腹泻的食物,术后宜进食易消化、易吸收、不产生腹胀的食物。同时,可食用部分预防便秘的蔬菜、水果,禁食辣椒等辛辣刺激食物,少吃生冷的食物。术后若发现有伤口水肿,可食用萝卜汤、绿豆汤、冬瓜汤等消肿食物。便秘者可进食富含膳食纤维以及润肠通便的食物^[27-28]。

问题9: 术后最佳的排便时间?

推荐: 不同术式,排便时间不同。

证据等级弱,推荐等级一般。

评论: 36.7%专家认为术后24 h即可排便,33.3%专家认为术后48 h排便,33.3%的专家认为自然排便即可,吻合器手术术后建议超过48 h后排便,其他术式可于术后24 h后排便。若出现腹泻时,各类手术(术中止血可靠的前提下)不需要忍便,均可无压力排便;有便血者,忌用力排便,且需要密切观察、及时处理。

问题10: 日间手术术前是否需要行常规的肠道准备?

推荐: 甘油灌肠剂110 mL灌肠1次。

证据等级弱,推荐等级较强。

评论: 76.7%专家认为术前甘油灌肠剂灌肠1次即可满足手术需求,33.3%专家认为术前自然排净大便即可。研究^[29-30]报道术前常规的机械性肠道准备属于应激因素,对老年患者的影响尤为显著,不利于术后康复;同时,麻醉后括约肌易松弛,术中容易出现灌肠残留液外渗而污染伤口,影响手术操作^[31],增强患者的紧张不适感。

因此,术前可采用甘油灌肠剂 1 支灌肠,个别患者可以采用肥皂水 800 mL 灌肠 1~2 次。

问题 11: 手术采用蛛网膜下腔阻滞麻醉,阿司匹林等抗凝药物麻醉科要求停用 1 周,如果采取静脉麻醉加局部麻醉,抗凝药物需要停用吗? 停用多久? 如果采用骶管麻醉又该如何处理?

推荐: 根据手术方式及服用抗凝药的基础疾病具体情况决定,必要时可请相关科室会诊。

证据等级一般,推荐等级一般。

评论: 23.3% 专家认为术前阿司匹林需停用 1 周,用低分子肝素替代,术后停用 3 d; 13.3% 专家认为术前停用 3 d, 用低分子肝素替代,术后停用 3 d; 23.3% 专家认为手术当天停用; 43.3% 专家认为可不停用。

若采用骶管麻醉, 66.7% 专家认为术前停用 1 周,用低分子肝素替代,术后停用 3 d, 防止椎管内出血风险; 10.0% 专家认为术前停用 3 d, 低分子肝素替代,术后停用 3 d, 尽量减少对内科疾病的影响; 10.0% 专家认为手术当天停用; 6.7% 专家认为可不停用,但对麻醉医师要求高,应熟练穿刺技术,尽量减少穿刺次数和损伤。

目前,术前是否停用麻醉或停用多久才能手术尚无定论,麻醉相关指南认为阿司匹林不增加椎管内麻醉风险,但为求谨慎,择期手术考虑停用 1 周,相关研究结果也不一致。Oscarsson A 等^[32]提出与不停用阿司匹林相比,术前 7 d 至术后 3 d 停用阿司匹林的 30 d 内主要不良心血管事件发生率差异有统计学意义($P < 0.05$)。Devereaux PJ 等^[33]提出与不停用阿司匹林相比,术前 1 d 至术后 7 d 停用阿司匹林在死亡或非致命心肌梗死的复合终点指标上及主要出血事件上无显著差异。研究^[34]发现,若长时间服用小剂量阿司匹林的患者突然停药,则会使血栓素 A_2 的活性增加,导致纤维蛋白溶解能力下降,并有可能促进血栓的形成。

因此,应根据患者全身状况,由麻醉医师评估麻醉风险,若必须采用蛛网膜下腔阻滞麻醉,抗凝药物停用期间可采用低分子肝素皮下注射替代,术前 12 h 停用。若采用静脉麻醉加局麻,可对患者围术期出血风险及血栓风险(Caprini 评分表^[35])进行评估。痔手术时间短,且术中止血可靠,因此低出血风险患者不需要停用抗凝药,当国际标准化比值(INR)控制在 2~4 时,可以不中断抗凝治疗,特别是在非环形痔上黏膜环切术

(NONRING-PPH)和铜离子电化学疗法使用中均不是禁忌证,术后出血并发症并不会增加。其他术式存在少量出血,可通过局部压迫止血进行控制,高出血风险可行桥接治疗,术前 72 h 停用抗凝药物,用低分子肝素替代,术前 12 h 停用低分子肝素^[36-39],术后根据出血情况尽早应用低分子肝素,3 d 后恢复应用抗凝药物,上述处理的前提条件是术者术中止血必须彻底、可靠。

问题 12: 日间手术术后如何预防尿潴留?

推荐: 中医药、针灸、穴位按摩、热敷,减少液体输入量,麻醉及手术精准操作,肛门填塞物不宜过多、过紧等。

证据等级强,推荐等级强。

评论: 86.7% 专家认为中医药、针灸、穴位按摩、热敷可以预防术后尿潴留, 43.3% 专家认为新斯的明等有效, 90.0% 专家认为麻醉及手术要精准, 96.7% 专家认为肛门填塞物不宜过多、过紧, 10.0% 专家认为止痛及减慢输液速度、减少输血量也是必要的。应对措施: ① 术前及术后进行宣教,消除患者焦虑、紧张情绪,手术前排空膀胱,研究^[40]表明,预防性口服 α 受体阻滞剂能显著降低痔术后尿潴留的发生率。② 术中减缓输液速度,减少输血量^[41]。③ 术后可用热毛巾或热水袋于耻骨联合上方膀胱区热敷,有尿意时可听水声等诱导排尿,应用膀胱挤压法,并减缓液体输入量及速度,可酌情放松肛门部敷料压迫,控制饮水量。④ 中医按摩具有一定的效果,如按摩气海、中极等穴位^[42]。若使用上述方法均无效,查体膀胱充盈,需及时导尿。

问题 13: 术后尿潴留导尿后,拔除尿管的时机?

推荐: 根据具体情况决定,必要时可请泌尿外科会诊。

证据等级较强,推荐等级一般。

评论: 56.7% 专家认为 24 h 后多数患者可拔除尿管,此时患者肛门疼痛减轻。20.0% 专家认为 72 h 可拔除尿管, 13.3% 专家认为 1 周可拔除尿管。研究^[43]报道, 72 h 是肛肠患者术后留置尿管拔除的适宜时间,产生的不良反应较少。若患者对尿管无法耐受,首次导尿量少于 400 mL,也可于术后 24 h 拔除,以减轻患者不适感;若患者合并前列腺增生等,可请泌尿外科会诊。

问题 14: 老年患者出现尿潴留后是否需要口服针对排尿障碍的药物?

推荐: 老年男性合并前列腺增生者可早期服用。

证据等级弱,推荐等级一般。

评论: 70.0% 专家认为老年男性患者大多合并前列腺增生,可早期服用 α_1 受体阻滞剂等西药或中成药等; 30.0% 专家认为出现尿潴留后口服药物效果不佳,导尿为首选,若有前列腺增生,需要术前早期配合服用药物。试验^[44-45]表明,预防性口服 α 受体阻滞剂能显著降低术后尿潴留的发生率。还有文献^[46]报道老年男性因存在隐性或显性前列腺肥大,所以术后尿潴留发生率高于普通患者,术后配合口服松弛尿道平滑肌的药物,可缩短导尿管留置时间。

问题 15: 术后是否应用抗生素?

推荐: 按照抗菌药物使用规范即可。

证据等级一般,推荐等级弱。

评论: 36.7% 专家认为不需要使用抗生素,但局部应保持清洁,可采用中药局部外用坐浴等; 36.7% 专家认为需要使用抗生素,使用时间 ≤ 24 h; 26.7% 专家认为需要使用抗生素,使用时间 < 48 h。《抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》以及《抗菌药物临床应用指导原则》中规定,痔手术抗生素预防应用时间应 ≤ 24 h, 不超过 48 h。研究^[47-48]证明肛门日间手术后手术部位感染发生率极低,预防性使用与不使用抗生素患者手术部位感染发生率的差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。研究^[49-50]表明局部伤口外用抗感染药膏如复方多粘菌素 B 软膏、百多邦换药较静脉输入抗生素能减少创面炎性水肿等发生,术后坐浴、伤口换药、局部理疗等中医综合疗法在预防术后感染方面的疗效与抗生素基本相同,可替代常规抗生素治疗。

问题 16: 日间手术患者的出院标准?

推荐: 根据麻醉、手术方式、伤口及排尿情况等综合评估。

证据等级弱,推荐等级一般。

评论: 30.0% 专家认为至少观察 6 h, 待麻醉作用消失、肢体功能恢复后即可出院; 33.3% 专家认为必须通畅排尿后方可出院,老年男性出现尿潴留的概率较高; 20.0% 专家认为需要同时满足上述 2 个条件; 20.0% 专家认为需要根据麻醉及手术方式等多方面因素综合决定,根据日间手术 Korttila^[51]的出院标准,患者出院必须经过麻醉和手术医师共同签字且生命体征平稳,无不良反应,所以患者术后必须排尿,腰麻患者术后至少观察 6 h。

问题 17: 术后疼痛程度如何判定可以出院?

推荐: 用药后疼痛视觉模拟评分法 (VAS) 评分小于 4 分。

证据等级弱,推荐等级一般。

评论: 60.0% 专家赞同用药后 VAS 评分小于 4 分可出院,50.0% 专家认为不用药时 VAS 评分小于 4 分才可出院,因 VAS 评分小于 4 分时,患者工作、生活基本不受影响。世界卫生组织 (WTO) 疼痛程度划分标准: 0 度为不痛; I 度 (1~3 分) 为轻度疼痛,表现为间歇痛,可不用药; II 度 (4~6 分) 为中度、持续疼痛,影响休息,需服用止痛药物。

问题 18: 术后出血状况如何判定可以出院?

推荐: 无出血。

证据等级弱,推荐等级一般。

评论: Vinson-Bonnet 等^[52-53]荟萃分析了 50 个临床研究,提出影响痔日间手术再入院率的 3 大原因为尿潴留、术后出血及疼痛。因此,73.3% 专家认为无出血方可出院,40.0% 专家认为伤口无活动性出血,包扎后无出血也可出院,关键是术中止血要彻底。当单次出血量 (新鲜出血) 较多时,不适合按照日间手术处理,应留院观察,避免医疗纠纷。

问题 19: 患者术后伤口出血,血色素无明显变化,是否需要手术止血?

推荐: 根据出血量决定。

证据等级弱,56.7% 专家赞同,推荐等级弱。

评论: 痔术后出血分为原发性出血和继发性出血^[54],若血色素无明显变化,需除外因失血导致血液浓缩的因素,切勿等到血色素发生变化再采取措施。临床主要观察出血量、是否有活动性出血,特别是出血的颜色,若为暗红色,可暂不采取手术方式,并嘱患者卧床、禁食、补液、扩容,局部采取创面压迫止血,放置排气管、控制排便,每 10~15 min 观察排气管出血变化情况,并注意监测生命体征,可配合使用止血药物。若有活动性出血,需及时手术止血。理论上 NONRING-PPH 和铜离子电化学疗法创面压迫止血是可靠的。

问题 20: 术后是否需要复查?

推荐: 需要复查。

证据等级弱,96.7% 专家赞同,推荐等级强。

评论: 术后复查非常必要,复查时间要根据伤口的恢复情况确定,主要查看创面愈合情况,预防伤口假性愈合、肛门狭窄等术后并发症,术后可

以每周门诊复查 1 次并结合电话随访,复查后根据伤口具体情况决定后续复查时间,一般连续 4 周,如果出现术后出血等情况,需告知患者及时就诊。

需要特别指出的是,任何一项新技术开展前都应该经过恰当的培训,或者由 3 名以上医务人员参加术前讨论和推演,并且有参加讨论的 3 名以上医务人员同时参与手术。

本共识于 2020 年完成并发布,今后随着《痔诊疗日间手术专家共识(2020 年版)》的实施,临床多中心、大数据的持续积累与更新,我们还会定期对其内容进行讨论、修订和更新,也欢迎更多的业内专家积极参与。

《痔诊疗日间手术专家共识(2020 年版)》牵头单位:北京肛肠学会专家共识审定委员会,北京众新胃肠肛门病研究所。

参考文献

- [1] Košorok P. Our criteria for PPH procedure in one day surgery practice[J]. Tech Coloproctol, 2010, 14(Suppl 1): S9 - S11.
- [2] Lee J H. Anesthesia for ambulatory surgery[J]. Korean J Anesthesiol, 2017, 70(4): 398 - 406.
- [3] 李东冰, 谢振年, 蔡亭, 等. 铜离子电化学疗法结合外痔切除手术治疗混合痔的临床观察[J]. 北京中医药, 2013, 32(2): 120 - 123.
- [4] 李东冰, 谢振年, 谭嗣伟, 等. 外痔切除缝合加内痔铜针术治疗混合痔[J]. 中国中西医结合外科杂志, 2019, 25(3): 370 - 373.
- [5] 李东冰, 谢振年, 蔡亭, 等. 外痔切除缝合加铜离子电化学疗法治疗混合痔 120 例临床观察[J]. 世界中医药, 2013, 8(9): 1015 - 1017.
- [6] 郝丽丽, 谢振年. 李东冰运用铜离子电化学疗法配合中药治疗内痔经验[J]. 河南中医, 2013, 33(8): 1227 - 1228.
- [7] 谢振年, 李东冰, 李权等. 铜离子电化学疗法治疗合并白血病的痔患者的临床观察[J]. 中国肛肠病杂志, 2008, 28(3): 47 - 48.
- [8] 嵇武, 刘亚萍, 戴玮. 我国日间手术开展现状与前景展望[J]. 中国实用外科杂志, 2020, 40(2): 199 - 202.
- [9] Bailey C R, Ahuja M, Bartholomew K, et al. Guidelines for day-case surgery 2019: guidelines from the association of anaesthetists and the British association of day surgery[J]. Anaesthesia, 2019, 74(6): 778 - 792.
- [10] 梁澄照, 吴瑞云, 李海霞. 日间改良痔切除手术的疗效观察[J]. 中国现代药物应用, 2017, 11(16): 76 - 77.
- [11] 王芳丽, 李东冰, 谢振年. 铜离子电化学疗法治疗有多种合并症的痔患者 179 例[J]. 陕西中医, 2010, 31(3): 317 - 319.
- [12] Fitz-Henry J. The ASA classification and peri-operative risk[J]. Ann R Coll Surg Engl, 2011, 93(3): 185 - 187.
- [13] Friedman Z, Chung F, Wong D T, et al. Ambulatory surgery adult patient selection criteria - a survey of Canadian anesthesiologists[J]. Can J Anaesth, 2004, 51(5): 437 - 443.
- [14] Eikaas H, Raeder J. Total intravenous anaesthesia techniques for ambulatory surgery[J]. Curr Opin Anaesthesiol, 2009, 22(6): 725 - 729.
- [15] Sungurtekin H, Sungurtekin U, Erdem E. Local anesthesia and midazolam versus spinal anesthesia in ambulatory pilonidal surgery[J]. J Clin Anesth, 2003, 15(3): 201 - 205.
- [16] Castellví J, Sueiras A, Espinosa J, et al. Ligasure versus diathermy hemorrhoidectomy under spinal anesthesia or pudendal block with ropivacaine: a randomized prospective clinical study with 1 - year follow - up[J]. Int J Colorectal Dis, 2009, 24(9): 1011 - 1018.
- [17] 蔡亭, 李东冰, 谢振年, 等. 铜离子电化学疗法治疗痔出血及脱出 1350 例疗效观察[J]. 中国医药导报, 2007, 4(33): 162 - 164.
- [18] 李东冰, 常宝志, 黄庭庭, 等. 铜离子电化学疗法治疗痔出血及痔脱出的临床研究[J]. 中国普外基础与临床杂志, 2003, 10(6): 596 - 599.
- [19] 叶宇飞, 徐慧岩, 曹科, 等. 分期中药熏洗对混合痔术后创面愈合的干预研究[J]. 中国中西医结合外科杂志, 2019, 25(6): 945 - 949.
- [20] 肖衡, 谭立新, 陈荣. 中药坐浴联合吻合器痔上黏膜环切术治疗环状脱垂性混合痔的疗效及优势探讨[J]. 世界中西医结合杂志, 2020, 15(2): 361 - 364.
- [21] 章媛媛, 王建民, 侯勇, 等. 痔瘘洗剂不同换药频率预防混合痔术后相关并发症 40 例临床观察[J]. 甘肃中医药大学学报, 2018, 35(1): 68 - 71.
- [22] 孙雪琴, 陈浩. 混合痔术后创面换药频率与伤口愈合时间关系的临床观察[J]. 结直肠肛门外科, 2013, 19(1): 50 - 52.
- [23] 丘春晖, 李万泉, 陈香玲. 中药配方药剂坐浴在痔疮手术切除后患者中的应用效果分析[J]. 中国实用医药, 2019, 14(31): 119 - 120.
- [24] Grucela A, Gurland B, Kiran R P. Functional outcomes and quality of life after anorectal surgery[J]. Am Surg, 2012, 78(9): 952 - 956.
- [25] 马琛, 曾宪东. 混合痔术后疼痛的中西医治疗进展[J]. 中国医药指南, 2019, 18(17): 27 - 28.
- [26] 王烨, 焦浩, 王海红. 中药加味四黄汤内服外敷与艾灸缓解混合痔术后疼痛 126 例的临床研究[J]. International Infections Diseases(Electronic Edition), 2020, 9(1): 156 - 157.
- [27] 刘莹, 田丹丹, 孙建华, 等. 个性化饮食干预对环状混合痔术后创面愈合及切口感染率的影响[J]. 中国肛肠病杂志, 2019, 39(11): 21 - 22.
- [28] 严姝霞, 葛永盛, 殷翠云, 等. 痔病术后中药熏洗技术规范及健康宣教[J]. 内蒙古中医药, 2015, 34(5): 172 -

- 173.
- [29] Chan M Y, Foo C C, Poon J T, et al. Laparoscopic colorectal resections with and without routine mechanical bowel preparation; a comparative study [J]. *Ann Med Surg (Lond)*, 2016, 9: 72–76.
- [30] 谭康联, 范小华, 张力, 等. 加速康复外科策略在Ⅲ~Ⅳ度混合痔患者围手术期的应用效果分析[J]. *结直肠肛门外科*, 2019, 25(2): 186–190.
- [31] 赵瑞琴, 林洁, 鲁开元. 术前自然排便对混合痔术后恢复的影响[J]. *临床普外科电子杂志*, 2016, 4(4): 50–53.
- [32] Oscarsson A, Gupta A, Fredrikson M, et al. To continue or discontinue aspirin in the perioperative period; a randomized, controlled clinical trial[J]. *Br J Anaesth*, 2010, 104(3): 305–312.
- [33] Devereaux P J, Mrkobrada M, Sessler D I, et al. Aspirin in patients undergoing noncardiac surgery[J]. *N Engl J Med*, 2014, 370(16): 1494–1503.
- [34] 安东, 陈庆良, 王联群, 等. 老年患者非体外循环冠状动脉旁路移植术前服用阿司匹林对早期预后的影响[J]. *中华老年医学杂志*, 2015, 34(4): 374–377.
- [35] Grant P J, Greene M T, Chopra V, et al. Assessing the caprini score for risk assessment of venous thromboembolism in hospitalized medical patients [J]. *Am J Med*, 2016, 129(5): 528–535.
- [36] Madrid C, Sanz M. What influence do anticoagulants have on oral implant therapy A systematic review[J]. *Clin Oral Implants Res*, 2009, 20(Suppl 4): 96–106.
- [37] 侯辉, 余智涛, 王悦辉. 抗凝治疗的内痔患者行吻合器痔上黏膜环切术的治疗体会[J]. *岭南现代临床外科*, 2014, 14(3): 317–320.
- [38] 闫伟国, 杨树森. 围术期新型抗血小板及抗凝药物管理[J]. *心血管病学进展*, 2018, 39(5): 776–780.
- [39] 闫素英, 冯燕军, 李希平, 等. 冠心病心脏支架术后鼻内镜手术持续不间断应用抗血小板药物对出血及再缺血事件的影响[J]. *心肺血管病杂志*, 2019, 38(12): 1205–1208.
- [40] 何媛明, 曾兰丹, 梁家芝, 等. 预防混合痔术后尿潴留的中西医研究进展[J]. *内蒙古中医药*, 2017, 36(18): 121–122.
- [41] Toyonaga T, Matsushima M, Sogawa N, et al. Postoperative urinary retention after surgery for benign anorectal disease: potential risk factors and strategy for prevention [J]. *Int J Colorectal Dis*, 2006, 21(7): 676–682.
- [42] 王艳, 骆兴芳. 混合痔术后患者发生尿潴留的危险因素 logistic 分析[J]. *中国医院统计*, 2020, 27(2): 109–111.
- [43] 邓利红. 肛肠患者术后尿管留置时间的探讨[J]. *中国医药科学*, 2012, 2(5): 54–55.
- [44] Akkoc A, Aydin C, Topaktas R, et al. Prophylactic effects of alpha-blockers, Tamsulosin and Alfuzosin, on postoperative urinary retention in male patients undergoing urologic surgery under spinal anaesthesia[J]. *Int Braz J Urol*, 2016, 42(3): 578–584.
- [45] Madani A H, Aval H B, Mokhtari G, et al. Effectiveness of tamsulosin in prevention of post-operative urinary retention: a randomized double-blind placebo-controlled study [J]. *Int Braz J Urol*, 2014, 40(1): 30–36.
- [46] 王娟, 温桂芬. 哈乐在预防老年男性腹股沟疝患者术后尿潴留中的应用及护理[J]. *现代临床护理*, 2008, 7(5): 15–16.
- [47] Khan K I, Akmal M, Waqas A, et al. Role of prophylactic antibiotics in Milligan Morgan hemorrhoidectomy-a randomized control trial[J]. *Int J Surg*, 2014, 12(8): 868–871.
- [48] Patel S A, Kucejko R J, Fazendin E A, et al. Are prophylactic antibiotic agents indicated in anorectal surgery for patients with human immunodeficiency virus[J]. *Surg Infect (Larchmt)*, 2017, 18(8): 924–928.
- [49] 张敏, 徐征, 黄泽林, 等. 凉血地黄汤加减预防混合痔术后感染的临床研究[J]. *中国肛肠病杂志*, 2019, 39(3): 52–54.
- [50] 邓洪毅, 曹子康, 段文志, 等. 百多邦用于痔术后开放性创面治疗效果观察[J]. *结直肠肛门外科*, 2015, 21(1): 44–46.
- [51] 杨莉. 日间手术的发展与管理[J]. *中医药管理杂志*, 2019, 27(3): 41–42.
- [52] Vinson-Bonnet B, Higuero T, Faucheron J L, et al. Ambulatory haemorrhoidal surgery: systematic literature review and qualitative analysis[J]. *Int J Colorectal Dis*, 2015, 30(4): 437–445.
- [53] 王葵儿, 谢琦, 居同法, 等. 加速康复外科理念用于混合痔日间手术的效果观察[J]. *浙江医学*, 2020, 42(6): 571–574.
- [54] 王柏雪, 张林. 痔术后出血 136 例临床分析[J]. *中国肛肠病杂志*, 2018, 38(1): 23–25.